角膜内皮移植术

2024 专家共识 · 正面

适应证/禁忌

内皮失代偿+基质相对正常；视轴瘢痕/活动炎症禁忌，低眼压相对禁忌；不完整晶状体-虹膜隔先重建。

2024 刊p114

术式选择

眼条件好倾向DMEK；前房/虹膜异常、后囊不完整、引流阀、可见度差或儿童倾向DSEK。炎症控制至少3月后考虑。

2024 刊p115

供体/植片

内皮≥2 500个/mm^2；DSEK供体≥10岁，DMEK≥50岁（资深可放宽）。直径7.75~8.00 mm；DSEK厚100~150 μm。

2024 刊p115–116

固定与预防

辨方向、减少接触；空气或10%~14% C_3F_8固定；周边虹膜切除防阻滞。DMEK不能使用黏弹剂固定。

2024 刊p116

角膜内皮移植术

2024 专家共识 · 背面

脱离处理

DSEK脱离>1/3或DMEK脱离>1/4面积再注气；<1/4可观察，扩大/水肿不退再注。DSEK中间区间及边界原文未明确。

2024 刊p117

眼压与体位

术后2~6 h密切测压，阻滞必要释气；仰卧面朝上、限活动30~60 min；避免揉眼挤压。2周内不用非接触测压。

2024 刊p114、117

复查重点

保持24 h足量气体，坐位避开6点钟方位虹膜切除口；可疑脱离做前节OCT；透明后尽早内皮计数、定期复查。

2024 刊p114、117

风险与缺项

疑感染尤其真菌尽早共焦。术后药物参考穿透移植；具体激素/免疫抑制剂量、递减及统一随访日程未明确。

2024 刊p117